

# CSBD ICD-11 6C72

Zaburzenie kompulsywnych zachowań seksualnych. Nie wysokie libido, nie niestandardowe preferencje. Kluczowe: utrata kontroli + cierpienie + 6 miesięcy.

**CZAS:** 15 min Diagnostyka i depatologizacja **ŹRÓDŁO:** WHO ICD-11 (2018); Kraus i wsp. (2018)

## JAK UŻYWAĆ

**1** · Poznaj 4 kryteria CSBD wg ICD-11 (sekcja 01) — wszystkie muszą wystąpić jednocześnie. **2** · Zrozum *różnicowanie* z wysokim libido, niestandardowymi preferencjami i konfliktem moralnym (sekcja 02). **3** · Wypełnij skrócony skrining wg HBI-19 (sekcja 03). **4** · Sprawdź *funkcję* zachowań — czego regulują, do czego służą (sekcja 04).

## DLACZEGO TO DZIAŁA

Zaburzenie kompulsywnych zachowań seksualnych (ang. *Compulsive Sexual Behaviour Disorder*, ICD-11 6C72) zostało wprowadzone przez WHO w 2018 r. po latach kontrowersji. Kluczowy wybór WHO: CSBD zostało zaklasyfikowane jako **zaburzenie kontroli impulsów**, *nie* jako uzależnienie — brak wystarczających dowodów na pełen model uzależnieniowy (Kraus i wsp. 2018, World Psychiatry). Cztery kryteria muszą występować łącznie: niezdolność kontroli, zaniedbywanie innych sfer życia, kontynuacja mimo szkód, znaczne cierpienie/dysfunkcja. Czas trwania: ≥6 miesięcy. Rozpowszechnienie: **3-6%** (Kraus 2018). *Kluczowe odróżnienia:* wysokie libido bez cierpienia *nie jest* CSBD; niestandardowe preferencje seksualne (BDSM, niemonogamia konsensualna) *nie są* CSBD; konflikt religijny / moralny — Grubbs i wsp. (2019) opisali fenomen *postrzeganego uzależnienia* (ang. *perceived addiction*) — osoby z konserwatywnymi przekonaniami religijnymi częściej identyfikują normalne zachowania seksualne jako „uzależnienie”, co zwiększa cierpienie *bez* realnego problemu klinicznego. Konsekwencja: **moralizowanie zamiast diagnozy** jest najczęstszym błędem klinicystów (Kraus 2018).

## 01 📋 Cztery kryteria ICD-11 — wszystkie muszą wystąpić

### 1 · NIEZDOLNOŚĆ KONTROLI

*próby ograniczenia bezskuteczne*

Liczne **nieudane próby** zmniejszenia częstotliwości, czasu albo intensywności. Postanowienia („dziś nie”) nie działają, mimo szczerej intencji.

### 2 · CENTRALNOŚĆ ŻYCIA

*zaniedbywanie zdrowia, relacji, pracy*

Zachowania seksualne stają się **centralnym punktem** życia. Zaniedbywanie pracy, snu, relacji, higieny, obowiązków. Inne sfery się sypią.

### 3 · KONTYNUACJA MIMO SZKÓD

*brak przyjemności lub jej spadek*

Mimo realnych konsekwencji (rozpad związku, problemy w pracy, choroby) — kontynuacja. Często bez radości: *kompulsja przewyższa hedonizm*.

### 4 · CIERPIENIE + 6 MIESIĘCY

*znacząca dysfunkcja*

Wzorec utrzymuje się co najmniej **6 miesięcy** i powoduje *znaczne cierpienie* lub upośledzenie społeczne, zawodowe, w innych ważnych obszarach.

## 02 🎯 Różnicowanie — co *nie jest* CSBD

### WYSOKIE LIBIDO

Częste, intensywne zachowania seksualne *bez* utraty kontroli, *bez* cierpienia i *bez* szkód funkcjonalnych. To wariant normy, *nie* zaburzenie.

### NIESTANDARDOWE PREFERENCJE

BDSM, niemonogamia konsensualna, kink. Jeśli konsensualne, bezpieczne, bez cierpienia i bez utraty kontroli — to *preferencje*, nie patologia.

### POSTRZEGANE UZALEŻNIENIE

Cierpienie z *przekonań* o uzależnieniu (konflikt religijny, kulturowy), nie z mechanizmu klinicznego (Grubbs 2019). Wymaga innej interwencji.

### 03 Skrócony skrining wg HBI-19 (Reid 2011)

Odpowiedz **uczciwie** w skali 1–5 (1 = nigdy, 5 = bardzo często). Wynik to *orientacja*, nie diagnoza — diagnozę stawia klinicysta.

#### Kontrola

- ☐ Próbowałem/-am ograniczyć moje zachowania seksualne i mi się nie udało.
- ☐ Czuję, że moje zachowania seksualne wymknęły się spod mojej kontroli.
- ☐ Zachowania seksualne kontynuuję mimo postanowień, że tego nie zrobię.

#### Konsekwencje

- ☐ Moje zachowania seksualne wpłynęły negatywnie na związek/-i.
- ☐ Zaniedbałem/-am obowiązki (praca, szkoła, dom) z powodu zachowań seksualnych.
- ☐ Wydaję na to więcej pieniędzy/czasu, niż mogę sobie pozwolić.

#### Regulacja emocji

- ☐ Sięgam po zachowania seksualne, gdy czuję się zestresowany/-a, samotny/-a lub zły/-a.
- ☐ Po epizodzie czuję się gorzej (wstyd, pustka, poczucie winy), nie lepiej.
- ☐ Próbowałem/-am wcześniej szukać pomocy w związku z tym problemem.

**Interpretacja orientacyjna:** 3+ pozycje zaznaczone jako 4–5 = warto skonsultować z klinicystą specjalizującym się w CSBD lub seksuologii klinicznej.

### 04 Funkcja zachowań — czego regulują?

CSBD najczęściej *nie* dotyczy seksu — dotyczy **regulacji**. Pytanie kluczowe: do czego to *służy*? Bez zrozumienia funkcji nie znajdziesz alternatywy.

#### CO CZUJĘ TUŻ PRZED EPIZODEM?

— stres, samotność, nuda, lęk, złość, smutek

#### CO PRÓBUJĘ UZYSKAĆ PRZECZ ZACHOWANIE?

— ulgę, pobudzenie, ucieczkę, kontrolę

#### NAJCZĘSTSZE WSPÓŁWYSTĘPOWANIA (KRAUS 2018)

- ☐ **Depresja** — seks/pornografia jako ucieczka od pustki i braku przyjemności
- ☐ **Lęk** — seks jako szybkie obniżenie napięcia
- ☐ **ADHD** — kompulsja jako poszukiwanie pobudzenia i nagrody natychmiastowej
- ☐ **Trauma (zwłaszcza seksualna)** — odtwarzanie wzorca, dysocjacja, kontrola
- ☐ **Uzależnienia substancyjne** — wspólne mechanizmy regulacji

**Klucz:** CSBD *nie* jest moralną kategorią. Nie oceniamy seksualności — oceniamy **utratę kontroli + cierpienie + szkody funkcjonalne**. Najczęstszy błąd kliniczny to *moralizowanie* („to za dużo seksu”) zamiast diagnozowania — pomija kryterium cierpienia/dysfunkcji. Drugi najczęstszy błąd: *fałszywie pozytywna diagnoza* u osób z konfliktem religijnym, gdzie cierpienie wynika z *przekonania* o uzależnieniu, nie z mechanizmu klinicznego (Grubbs 2019, ang. *perceived addiction*). Jeśli zachowania **nie** powodują cierpienia ani szkód funkcjonalnych — to *preferencje*, nie zaburzenie. Jeśli powodują — leczenie istnieje (Hallberg 2019: CBT online,  $d = 0,66$ ).